

# DIAGNOSTIC ET SURVEILLANCE DE LA GROSSESSE

## I. Introduction

- Généralistes, médecins spécialistes: pain quotidien++++
- 3/4 cas : évolution et fin sur mode physiologique
- 1/3: grossesse et accouchement à RISQUE
- Le praticien :
  - Diagnostiquer une Grossesse normale
  - Dépister et référer à temps une grossesse à risque
  - Traitement préventif
  - Pronostic de l'accouchement
- But : Diminuer mortalité morbidité materno-foetale

### QE : Encadré 1. Différents suivis et demandes d'avis possibles pour les grossesses.

- **Suivi A** : lorsque la grossesse se déroule sans situations à risque ou lorsque ces situations relèvent d'un faible niveau de risque, le suivi régulier peut être assuré par une sage-femme ou un médecin (généraliste, gynécologue médical ou gynécologue-obstétricien) selon le choix de la femme
  - Avis A1 : L'avis d'un gynécologue-obstétricien et/ou d'un autre spécialiste est conseillé
  - Avis A2 : L'avis d'un gynécologue-obstétricien est nécessaire. L'avis complémentaire d'un autre spécialiste peut également être nécessaire
- **Suivi B** : lorsque les situations à risque détectées permettent de statuer sur un niveau de risque élevé, le suivi régulier doit être assuré par un gynécologue-obstétricien.

- Rôle du généraliste :
  - Formation théorique et pratique
  - Evaluation du niveau de risque référer → Référer à temps auprès de l'obstétricien

## II. Consultation pré-conceptionnelle

### 1. Interrogatoire :

- Pathologie familiale
- Pathologie chronique: HTA, diabète, thrombophilie
- Tabagisme, drogues
- Médicaments: antiépileptiques (entraînent une carence en folates) , psy

### 2. Examen clinique:

- Taille, poids, IMC
- Seins, Examen gynécologique +FCV (si nécessaire)

### 3. Examens complémentaires :

- Groupe sanguin
- Sérologie rubéole et toxoplasmose
- Proposer sérologie VIH, VHC

### 4. CAT: avant l'arrêt de contraception :

- Rappel vaccin tétanos -polio-diphtérie (si vaccin > 10 ans)
- Vaccin contre rubéole, varicelle, oreillons, coqueluche,
- Obésité: régime
- Sevrage des habitudes addictives
- Conseil génétique

| Vaccins autorisés     | Vaccins théoriquement déconseillés mais pouvant être utilisés <sup>(1)</sup> | Vaccins à éviter                     | Vaccins contre-indiqués |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Grippe saisonnière    | Encéphalite à tiques                                                         | Coqueluche                           | Oreillons               |
| Grippe A (H1N1)v      | Fièvre jaune (gravité de la maladie)                                         | Diphtérie (préférer valence réduite) | Rougeole                |
| Hépatite B            | Fièvre typhoïde                                                              | Papillomavirus                       | Rubéole                 |
| Poliomyélite inactivé | Hépatite A                                                                   | Pneumocoque                          | Varicelle               |
| Tétanos               | Méningocoque A/C                                                             |                                      |                         |
|                       | Rage                                                                         |                                      |                         |
|                       | Tuberculose (si zone à haut risque)                                          |                                      |                         |

(1) En raison de la gravité potentielle de la maladie et/ou d'un risque élevé de contamination (voyage en zone endémique, contexte épidémique ou professionnel, exposition intrafamiliale).

QE!!

• **VACCIN ANTI COVID 19 +++ des TI**

- Pathologie chronique: CI à la grossesse? Programmation de Gsse? 
- Acide folique (1 mois <conception-1ère T) ⇒ *Rôle dans la division cellulaire et le développement du SN fœtal* ⇒ *Carence en folates est une FDR de la spina bifida*

## III. Première consultation prénatale

- **Objectifs : QEE +++**
  - ✓ Etablir le diagnostic de la grossesse
  - ✓ Dater la grossesse
  - ✓ Évaluer les FDR
  - ✓ Prescrire les examens complémentaires,
  - ✓ Conseiller l'hygiène de vie
  - ✓ Établir un plan de surveillance adapté

QE!!



### 1<sup>ère</sup> CPN < 10 SA

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Etablir le diagnostic de la grossesse                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interrogatoire, examen clinique</li> <li>• Bêta-HCG qualitatif en cas de doute</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b. Dater la grossesse                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Echographie de datation dans les cas incertains</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| c. Réaliser un examen clinique général et gynécologique                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prise de la PA, mesure de la taille, du poids, examen des seins, frottis cervical (si plus de 2 à 3 ans) à la recherche d'une vaginite</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              |
| d. Recherche des facteurs de risque ciblée en particulier sur les pathologies chroniques (HTA, diabète)                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptation du traitement en cours</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| e. Proposer le dépistage des anomalies chromosomiques fœtales                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dépistage combiné du 1er trimestre de la grossesse, associant mesure de la clarté nucale (échographie réalisée entre 11 et 13 SA et 6 jours) et dosage des marqueurs sériques (PAPP-A et b-hCG libre) (b)</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| f. Prévenir les malformations du tube neural (jusqu'à 8 SA)                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• prendre quotidiennement un supplément contenant plus de 400 µg (0,4 mg) d'acide folique dans le but de réduire le risque d'anomalies du tube neural (ATN)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| g. Donner une information orale sur le suivi général de la grossesse étayée par une information écrite disponible dans le carnet de maternité | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alimentation et mode de vie, risques infectieux alimentaires,</li> <li>• organisation des soins au sein d'un réseau périnatalité, droits</li> <li>• et avantages liés à la maternité, examens de dépistage,</li> <li>• sensibilisation aux effets du tabagisme (d), de la consommation</li> <li>• d'alcool(e), de l'usage de drogues(f) et de médicaments</li> <li>• tératogènes(g)</li> </ul> |

## 1. Etablir le diagnostic de la grossesse

### a. Signes fonctionnels

- Aménorrhée
- Signes sympathiques: digestifs, neurologiques, urinaires, sensation de gonflement général (nausées, vomissements, vertige, anxiété, pollakiurie ...)

### b. Examen clinique:

#### ❖ Seins :

Tendus, augmentation de volume.

Aréoles: tubercules de Montgomery, hyperpigmentées, bombées en verre de montre.

Réseau veineux sous-cutané de « Haller »

#### ❖ Utérus

**Spéculum** : col violacé lilas, glaire pauvre cassante épaisse = Bouchon muqueux

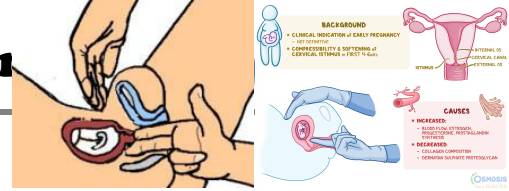
**TV +palper abdominal**: utérus volume

**Signe de Noble**

8SA →

10 SA →





## c. Examen paraclinique: QE !

### ❖ Dosage des Beta-HCG :

- **Qualitatif** : urines ou sérum
  - Faux positif et faux négatif
  - >4j du retard des règles
- **Test quantitatif** : 8-10j d ovulation
  - ❖ **Echographie** : Abdominale mais surtout endovaginale 11 SA -13SA+6j

### • Plus tôt si :

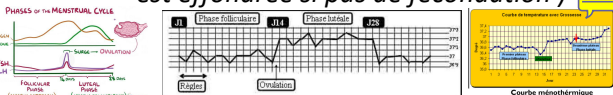
- DDR méconnue, cycles irréguliers, grossesse sous contraception, post partum, post abortum, aménorrhée
- Métorrhagies, douleurs abdomino-pelviennes...

### • Objectifs:

- ✓ Confirmation, localisation .datation et évolutivité
- ✓ Première approche morphologique
- ✓ Mesure de la clarté nucale
- ✓ Chorionicité des grossesses multiples
- ✓ Pathologie gynécologique, malformation utérine

## Diagnostic facile 2/3

- ❖ CM réguliers
- ❖ Aménorrhée secondaire
- ❖ DDR précise,
- ❖ Signes sympathiques de grossesse,
- ❖ Courbe thermique avec décalage ovulatoire net et plateau > 18 jours. ( Normalement la température est effondrée si pas de fécondation )



## 2. Dater la grossesse : Il y a deux façons de dater une grossesse :

### a. A partir de la date du premier jour des dernières règles :

- Terme théorique = date des dernières règles (DDR) + 14 jours (début de grossesse) + 9 mois
- Soit 41 semaines d'aménorrhée.
- Exemple: DDR:14/12/2011 → début de grossesse:28/12/2011 → terme théorique (vous ajoutez 9 mois ou, vous pouvez aussi retrancher 3 mois et ajouter 1 an) : 28/09/2012.

### b. Datation échographique entre 7 et 12 SA

- Par la mesure de la **longueur cranio-caudale (LCC)** de l'embryon estimant l'âge gestationnel à +/- 3 jours. Au 1<sup>ère</sup> trimestre, la croissance embryonnaire est la même pour tous les embryons. C'est le **moyen le plus fiable** pour dater une grossesse.
- Le taux quantitatif d'hCG ne permet pas de dater une grossesse, et son dosage n'a plus aucun intérêt à partir du moment où une grossesse clinique intra-utérine est visible à l'échographie

## 3. Évaluer les FDR :

- Examen clinique : poids, taille, TA, Seins, Bandelette urinaire : protéinurie .glycosurie...
- Evaluer le risque :

## Signe de Hégar

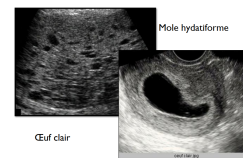
## Bruits du cœur fœtal, perçus par Doppler dès la 12 SA

### ❖ Pigmentation générale:

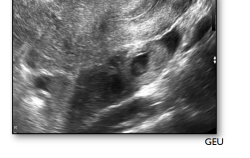
- Taches brunâtres sur le front et joues: chloasma, masque de grossesse
- Ligne brune abdominale
- Cicatrices hyperpigmentées
- Vulve: hyperpigmentées, œdème des lèvres



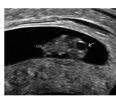
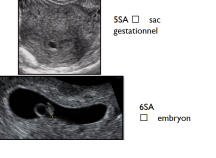
Echo TI=Confirmer la grossesse



Echo TI =Localiser la grossesse



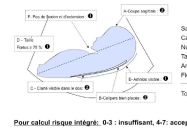
Echo TI =Évolution normale



echo TIDater : Mesure de la LCC



Score de Herman



Pour calculer le risque intégré: 0-3 : insuffisant, 4-7 : acceptable, 8-9 : excellent

Echo TI Pathologie gynécologique, malformation utérine

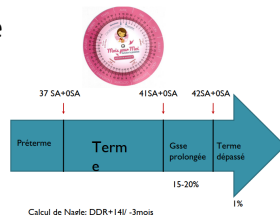


Echo TI=Grossesses multiples



## Diagnostic difficile 1/3

- ❖ Cycles menstruels irréguliers,
- ❖ DDR imprécise.
- ❖ Pas de retour de couches = 1<sup>ère</sup> règles après l'accouchement
- ❖ Grossesse débutée juste après arrêt de la contraception orale
- ❖ Métorrhagie 1<sup>ère</sup> trimestre
- ❖ Pré-ménopause
- ❖ Discordance interrogatoire / clinique



## Groupe 1 : Terrain

- Age: <18ans, >35ans
- Taille < 150cm
- Poids < 40 Kg (IMC 17, 5Kg/m2 ou > 80 Kg) (IMC > 40Kg/m2)
- Infertilité > 5 ans
- Maladie génétique: héréditaire

## Groupe 2: ATCD généraux

- HTA
- Diabète
- Pathologie: pulmonaire, vertébrale, cardiaque, vasculaire, neuropsychiatrique
- Hépatite B
- VIH

## Groupe 3: ATCD obstétricaux

- Fausse couche à répétition
- Accouchements prématurés
- Malformation utérine connue
- Accouchements de dysmatures
- Morts périnatales
- Séquelles psychomotrices

## Groupe 4: Pathologie de la grossesse

- Vomissements gravidiques
- Traumatisme
- Grossesse gémellaire
- Immunisation RH
- Infection urinaire
- Hémorragie T2 T3
- Ictère

### 4. Prescrire les examens complémentaires : QE ++

#### Examens obligatoires

- Groupe sanguin et Rh
- Coombs indirect et RAI: 3, 6, 8, 9 mois si Rh-, début de grossesse si Rh+ (ATCD de grossesses et/ou transfusion)
- Sérologie syphilis VDRL.TPHA
- Sérologie rubéole
- Sérologie toxoplasmose

#### Examens obligatoirement proposés

- Sérologie VIH
- Dépistage combiné TI des anomalies chromosomiques fœtales: mesure de clarté nucale + dosage des marqueurs sériques: (PAPP-A, B HCG libre) → Marqueurs de la trisomie 21  
↳ Mais la patiente n'est pas obligée d'accepter

#### Examens prescrits selon les circonstances :

- ECBU
- PV +/- recherche de vaginose bactérienne
- Sérologie de l'hépatite B
- Sérologie hépatite C
- NFS + ferritine sérique
- Groupe Rh du fœtus
- FCV (si dernier date de >2-3ans)

#### Examens à ne pas faire

- Sérologie CMV
- Sérologie parvovirus B19  
↳ Pas de traitement  
↳ Coût élevé  
↳ Difficulté d'interpréter les sérologies

### 5. Conseiller l'hygiène de vie

- ✓ Arrêt du tabac et boissons alcoolisées
- ✓ Règles d'hygiène pour prévenir la listériose
- ✓ Alimentation riche en folates, iode, fer
- ✓ Prescription systématique de vitamine D ? → Eviter l'hypocalcémie néonatale
- ✓ Supplémentation 400mcg/j AC folique en préventif et 4-5mg/j si ATCD d'AFTN = Anomalie de fermeture du tube neural
- ✓ Si anémie ferriprive : 30 à 60 mg/j de fer

#### Encadré 1. Différents suivis et demandes d'avis possibles pour les grossesses.

- **Suivi A** : lorsque la grossesse se déroule sans situations à risque ou lorsque ces situations relèvent d'un faible niveau de risque, le suivi régulier peut être assuré par une sage-femme ou un médecin (généraliste, gynécologue médical ou gynécologue-obstétricien) selon le choix de la femme  
⇒ Avis A1 : L'avis d'un gynécologue-obstétricien et/ou d'un autre spécialiste est conseillé  
⇒ Avis A2 : L'avis d'un gynécologue-obstétricien est nécessaire. L'avis complémentaire d'un autre spécialiste peut également être nécessaire
- **Suivi B** : lorsque les situations à risque détectées permettent de statuer sur un niveau de risque élevé, le suivi régulier doit être assuré par un gynécologue-obstétricien.

**Tableau 1.** Types de suivi et structure recommandés pour l'accouchement en fonction des situations à risque identifiées chronologiquement au cours de la grossesse (liste indicative non limitative) (accord professionnel).

| Période préconceptionnelle ou 1 <sup>re</sup> consultation de grossesse                                                                                                                                                  |                         |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| Situations à risque                                                                                                                                                                                                      | Suivi                   | Structure                              |
| <b>FACTEURS DE RISQUE GÉNÉRAUX</b>                                                                                                                                                                                       |                         |                                        |
| <b>Âge</b> (moins de 18 ans et au-delà de 35 ans)                                                                                                                                                                        | A1<br>pour les extrêmes | Unité d'obstétrique si facteur isolé   |
| <b>Poids</b> (IMC inférieur ou égal à 17,5 kg/m <sup>2</sup> et supérieur ou égal à 40 kg/m <sup>2</sup> pour obésité morbide)                                                                                           | A1<br>pour les extrêmes | À adapter pour les extrêmes            |
| <b>Facteurs individuels et sociaux, vulnérabilité émotionnelle</b> (rupture, deuil, isolement)                                                                                                                           | A                       | Unité d'obstétrique                    |
| <b>Risque professionnel</b> (exposition avérée par des produits toxiques ou tératogènes par exemple)                                                                                                                     | A2                      | À adapter                              |
| <b>Antécédents familiaux</b><br>- Pathologies génétiquement transmissibles ou entraînant une incidence accrue dans la descendance (proches au 1 <sup>er</sup> degré)<br>- Pathologies génétiques : caryotypique, génique | A2                      | À adapter en fonction de l'anomalie    |
| <b>TOXIQUES</b>                                                                                                                                                                                                          |                         |                                        |
| <b>Sevrage alcoolique</b>                                                                                                                                                                                                | A1                      | À adapter en fonction des conséquences |
| <b>Prise de médicaments potentiellement tératogènes ou de toxiques en préconceptionnel</b> (exposition avérée)                                                                                                           | A2                      | À adapter                              |

**ANTÉCÉDENTS PERSONNELS PRÉEXISTANTS NON GYNÉCOLOGIQUES****Antécédents chirurgicaux généraux et neurochirurgicaux**

|                                                                                                                                |            |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| <b>Traumatisme du bassin ou du rachis</b> (fracture déplacée)                                                                  | A2         | À adapter                                |
| <b>Chirurgies, pathologies cardiaques</b> (avec retentissement hémodynamique) <b>dont Marfan, Ehlers-Danlos et autres</b>      | B          | À adapter                                |
| <b>Pathologie rétinienne</b> (dont myopie grave)                                                                               | A1         | Unité d'obstétrique                      |
| <b>Hémorragie cérébrale, anévrisme</b>                                                                                         | B          | À adapter                                |
| <b>Antécédents médicaux et pathologies préexistantes non gynécologiques</b>                                                    |            |                                          |
| <b>Usage de drogues illicites</b> (héroïne, ecstasy, cocaïne sauf cannabis) <b>et substituts</b> (méthadone) <b>et sevrage</b> | A1         | Unité d'obstétrique si antécédent ancien |
| <b>Hypertension artérielle</b>                                                                                                 | B          | À adapter                                |
| <b>Diabètes</b>                                                                                                                | <u>B</u>   | À adapter                                |
| <b>Thrombose veineuse profonde- embolie pulmonaire</b>                                                                         | B          | À adapter                                |
| - <b>Affections thyroïdiennes équilibrées</b> (selon la pathologie) <b>hors</b> maladie de Basedow                             | A1         | Unité d'obstétrique                      |
| - <b>Maladie de Basedow</b>                                                                                                    | B          | À adapter                                |
| <b>Épilepsie traitée ou non traitée</b>                                                                                        | A2 précoce | À adapter                                |
| - <b>Asthme ou pathologie pulmonaire</b> (avec incidence sur la fonction respiratoire)                                         | B          | À adapter                                |
| - <b>Asthme modéré, ancien, contrôlé</b>                                                                                       | A          | Unité d'obstétrique                      |
| <b>Maladies inflammatoires digestives</b> (maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique traitée)                               | A2 précoce | À adapter                                |

|                                                                                                                                                                                       |            |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| <b>Drépanocytose et autres hémoglobinopathies :</b>                                                                                                                                   |            |                                            |
| - mère homozygote                                                                                                                                                                     | B          | À adapter                                  |
| - mère hétérozygote                                                                                                                                                                   | A2         | Unité d'obstétrique                        |
| <b>Anomalies de la coagulation, thrombopénie maternelle et purpura thrombopénique auto-immun</b>                                                                                      | B          | À adapter                                  |
| <b>Maladies de système et maladies rares</b> (sclérose en plaques, Addison, Cushing, LED, SAPL, sclérodermie, polyarthrite rhumatoïde)                                                | B          | À adapter                                  |
| - Néphropathie                                                                                                                                                                        | B          | À adapter                                  |
| - Uropathie                                                                                                                                                                           | A2         | Unité d'obstétrique si sans retentissement |
| <b>Affection hépatique</b> (cholestase, maladie biliaire, adénome)                                                                                                                    | A2 précoce | À adapter                                  |
| <b>Chimiothérapie et radiothérapie</b>                                                                                                                                                | A2         | Unité d'obstétrique                        |
| <b>Maladies psychiatriques sévères</b> (pathologie elle-même et facteurs de risque liés à la thérapeutique) : <b>schizophrénie, troubles bipolaires, syndromes dépressifs sévères</b> | A2 précoce | À adapter                                  |
| <b>Maladies infectieuses</b>                                                                                                                                                          |            |                                            |
| <b>Séropositivité VIH</b>                                                                                                                                                             | B          | À adapter                                  |
| <b>Portage antigène HBs</b>                                                                                                                                                           | A1         | Unité d'obstétrique                        |
| <b>Hépatite C ou B active</b>                                                                                                                                                         | A2         | À adapter                                  |
| <b>ANTÉCÉDENTS PERSONNELS PRÉEXISTANTS GYNÉCOLOGIQUES</b>                                                                                                                             |            |                                            |
| <b>Pathologies utéro-vaginales</b>                                                                                                                                                    |            |                                            |
| <b>Malformation utéro-vaginales</b>                                                                                                                                                   | B          | À adapter                                  |
| <b>Mutilations sexuelles</b>                                                                                                                                                          | A1         | À adapter                                  |

|                                                                                                                |          |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Chirurgie cervico-utérine</b>                                                                               |          |                                                                     |
| <b>Chirurgie du prolapsus</b> (reconstruction pelvienne, traitement)                                           | A2       | À adapter                                                           |
| <b>Conisation</b> (amputation cervicale, cryothérapie, résection à l'anse)                                     | A2       | À adapter                                                           |
| <b>Myomectomie, utérus cicatriciel</b> (cicatrice gynécologique)                                               | A2       | À adapter                                                           |
| <b>Distylbène syndrome</b>  | B        | À adapter                                                           |
| <b>ANTÉCÉDENTS PERSONNELS LIÉS À UNE GROSSESSE PRÉCÉDENTE</b>                                                  |          |                                                                     |
| <b>Antécédents médicaux</b>                                                                                    |          |                                                                     |
| <b>Infections urinaires récidivantes (plus de 2) hors uropathie</b>                                            | A1       | Unité d'obstétrique                                                 |
| <b>Diabète gestationnel</b>                                                                                    | A        | À adapter en fonction d'une récurrence au cours de la grossesse     |
| <b>Antécédents obstétricaux</b>                                                                                |          |                                                                     |
| <b>Césarienne</b>                                                                                              | A2       | À adapter                                                           |
| <b>Incompatibilité fœto-maternelle</b> (érythrocytaire et plaquettaire)                                        | <u>B</u> | À adapter                                                           |
| <b>Béance cervicale ou cerclage, selon la pathologie</b>                                                       | B        | À adapter en fonction du terme                                      |
| <b>Hypertension gravidique</b>                                                                                 | A2       | À adapter en fonction de la récurrence                              |
| <b>Pré-éclampsie, syndrome de HELLP</b>                                                                        | B        |                                                                     |
| <b>Fausses couches répétées au cours du 1<sup>er</sup> trimestre :</b>                                         |          |                                                                     |
| - sans étiologie                                                                                               | A2       | Unité d'obstétrique si évolution de la grossesse sans complications |
| - avec étiologie SAPL                                                                                          | B        |                                                                     |
| <b>Fausses couches tardives au cours du 2<sup>e</sup> trimestre</b>                                            | B        | À adapter en fonction de la récurrence                              |

|                                                                                 |                 |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Accouchement prématuré                                                          | A2 précoce<br>B | À adapter en fonction de la récurrence                              |
| Interruption volontaire de grossesse (IVG) (plus de 2)                          | A1              | Unité d'obstétrique                                                 |
| Interruption médicale de grossesse (IMG)                                        | A2              | À adapter en fonction du motif de l'IMG et de la situation actuelle |
| Hématome rétroplacentaire                                                       | B               | À adapter en fonction du déroulement de la grossesse                |
| - Retard de croissance intra-utérin sévère (RCIU) (< 3 <sup>e</sup> percentile) | B               | À adapter                                                           |
| - Mort fœtale <i>in utero</i> (MFIU) d'origine vasculaire                       | B               | À adapter                                                           |
| <b>Antécédents liés à l'enfant à la naissance</b>                               |                 |                                                                     |
| Asphyxie périnatale avec séquelles                                              | B               | À adapter                                                           |
| Mort périnatale inexpliquée                                                     | B               | À adapter                                                           |
| Anomalie congénitale ou génétique                                               | A2              | À adapter                                                           |
| <b>Antécédents liés à l'accouchement précédent</b>                              |                 |                                                                     |
| Hémorragies <i>post-partum</i> sévères                                          | A1              | À adapter                                                           |
| Déchirure du sphincter anal                                                     | A2              | Unité d'obstétrique                                                 |
| Dépression du <i>post-partum</i> , stress post-traumatique                      | A               | Unité d'obstétrique                                                 |
| Psychose puerpérale                                                             | A2              | À adapter                                                           |
| Dystocie des épaules                                                            | A1              | À adapter                                                           |

❖ A quel rythme ?

- Idéalement **7** consultations prénatales 
- Minimum **4** consultations prénatales
- Si **GAR** : suivi plus rapproché

IV. Deuxième consultation prénatale

- Quand? Avant 15SA
- Interrogatoire
- Examen clinique
- Fixer la date présumée d'acct

**Déroulement de la 2e consultation avant 15 SA révolues.**

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Établir la déclaration de grossesse et fixer la date présumée d'accouchement                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| b. Réaliser un examen clinique                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prise de la pression artérielle ; mesure du poids ; <u>mesure de la hauteur utérine à partir du 4e mois</u> ; si possible recherche des bruits du cœur fœtal ( <i>à partir de 12 SA</i> )</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
| c. Proposer le dépistage des anomalies chromosomiques fœtales                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marqueurs du 2e trimestre en l'absence d'un dépistage combiné au 1er trimestre (<math>\alpha</math>FP, <math>\beta</math> HCG libre +/- oestradiol non conjugué )</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| d. Proposer systématiquement un entretien individuel ou en couple et rechercher d'éventuels facteurs de stress et toute forme d'insécurité (précarité, insécurité affective au sein du couple ou de la famille) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Expression des attentes et besoins de la femme et du couple ; repérage des situations de vulnérabilité, des signes de violence domestique et orientation vers un éventuel soutien spécialisé (PMI, social, psychologique, etc.) ou un réseau d'écoute, d'appui, d'accompagnement des parents ; informations sur les ressources de proximité ; liens sécurisants avec les partenaires du réseau périnatalité les plus appropriés</li> </ul> |
| e. Conseiller la participation aux séances de préparation à la naissance et à la parentalité (collectives ou individuelles) en expliquant leurs objectifs                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Examens à prescrire au cours de la 2<sup>e</sup> consultation de grossesse.Systématiquement

- ❖ Glycosurie et protéinurie
- ❖ Sérologie de la toxoplasmose en cas de négativité du résultat précédent
- ❖ Sérologie de la rubéole en cas de négativité du résultat précédent (jusqu'à 18 SA)

- Marqueurs biologiques T2 (en l'absence de dépistage du T1)
- Entretien individuel ou en couple (facteurs de stress et d'insécurité affective)
- Conseiller les séances de préparation à la naissance et parentalité

V. Consultations intermédiaires : QEE ++

- Quand ? Chaque mois à partir de 4 mois

1. Interrogatoire:

- Fièvre, éruption
- Saignement
- Prurit, écoulement vaginal
- DI pelviennes, CU physiologiques
- Signes urinaires
- Mouvements actifs fœtaux : dès 20SA (primipare), avt (multipare)
- Petits maux de grossesse

2. Examen clinique:

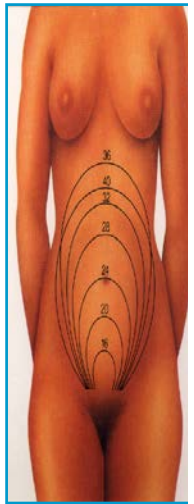
## Déroulement des consultations (Cs) prénatales intermédiaires

|                                                                                                                                                                                                                                    | 3e Cs   | 4e Cs   | 5e Cs   | 6e Cs   | 7e Cs   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Mois de gestation                                                                                                                                                                                                                  | 4e mois | 5e mois | 6e mois | 7e mois | 8e mois |
| Examen clinique (poids, prise de la tension artérielle ; mesure de la hauteur utérine ; recherche des bruits du cœur et des mouvements fœtaux ; recherche des signes fonctionnels urinaires ; recherche des contractions utérines) | X       | X       | X       | X       | X       |
| Évaluation de la présentation fœtale                                                                                                                                                                                               | -       | -       | -       | -       | X       |
| Cs de pré-anesthésie                                                                                                                                                                                                               | -       | -       | -       | -       | X       |

- Prise de poids : 1kg/mois (5-12kg) → L'obésité est un FDR de pré-éclampsie
- TA ++++
- OMI
- Conjonctives
- Varices vulve, MI
- Lésions de grattage, vergeture

Hauteur utérine

- Entre 16 et 32 SA :
- ❖ HU normale en cm =
  - ❖ de [nombre de semaines d'aménorrhée révolues - 4]
  - ❖ Au [nombre de semaines d'aménorrhée révolues + 1].
  - ❖ Exemple : à 30 SA, la hauteur utérine est normalement de 26 à 31 cm.
  - ❖ De 32 SA au terme de la grossesse : la hauteur utérine augmente d'environ 0.5 cm par semaine, soit 2 cm/mois
  - ❖ D'autres références en Obstétrique proposent cette règle :
- De 4 à 7 mois : La hauteur utérine (en centimètre) = nombre de mois de grossesse X 4 (7mois : HU=7x4=28cm)
- Au 8e et 9e mois : La hauteur utérine augmente d'environ 0,5 cm par semaine, soit 2 cm par mois ou retrancher 2cm (8mois : HU=8X4-2=30cm)



- Règles à respecter pour mesurer
  - ✓ Position de la patiente : Décubitus dorsal
  - ✓ Vessie et rectum vides,
  - ✓ Tête légèrement surélevée,
  - ✓ MI en position de fléchie et modérément écartés,
  - ✓ Bras le long du corps
- Mesure :
  - ✓ Repérer le fond utérin
  - ✓ Placer l'extrémité du centimètre au bord supérieur de la symphyse pubienne et l'y maintenir avec l'index de la main droite,
  - ✓ Guider le centimètre le long du grand axe de l'utérus (qui n'est pas forcément la ligne médiane),
  - ✓ Mettre la main gauche verticalement au niveau du fond et faire la mesure,
  - ✓ Vérifier une ou deux fois la valeur trouvée.

- Palpation abdominale: plan du dos

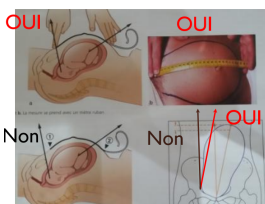
• BCF

• Spéculum : si nécessaire

• TV: score de bishop MA → Evaluation des conditions locales avant le déclenchement du travail

• Etat fœtal:

- Echographies: 20-25 SA 30-35SA
- RCF



5 critères évalués :

|                                                                          | 0           | 1           | 2           | 3                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Dilatation (cm)                                                          | 0           | 1-2         | 2-4         | ≥ 5                |
| Effacement (%)                                                           | 0-30        | 40-50       | 60-70       | ≥ 80               |
| Consistance                                                              | ferme       | moyenne     | molle       | ---                |
| Position du col                                                          | postérieur  | MI position | antérieur   | ---                |
| Hauteur de la présentation (en rapport au bord supérieur de la symphyse) | Haute (≥ 3) | Moyenne (2) | Basse (1/0) | En appui (≤ -1/-2) |

Interprétation :

| Score total | Signification     | Conduite à tenir                                                    |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ≥ 9         | Col favorable     | Déclenchement possible (travail probable)                           |
| 4-8         | Col défavorable   | Préparation cervicale (médication pharmacologique, balnéaire, etc.) |
| 0-3         | Col intermédiaire | Surveillance ou médication cervicale selon le contexte              |

Valeurs du scores : de 0 à 13 ; score > 9 : pronostic favorable (travail de moins de 4 heures chez les multipares)

| Paramètres                                                                 | 0                          | 1                           | 2                           | 3                               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Dilatation du col utérin                                                   | fermé                      | 1 - 2 cm                    | 3 - 4 cm                    | > 5 cm                          |
| Effacement du col utérin                                                   | 0 - 30%                    | 40 - 50%                    | 60 - 70%                    | > 80 %                          |
| Consistance du col utérin                                                  | ferme                      | moyenne                     | molle                       |                                 |
| Position du col utérin                                                     | postérieure                | centrale                    | antérieure                  |                                 |
| Positionnement de la présentation fœtale par rapport aux épines sciatiques | mobile<br>(3 cm au-dessus) | amorcée<br>(2 cm au-dessus) | fixée<br>(< 1 cm au-dessus) | engagé<br>(1 - 2 cm au-dessous) |

**Examens à prescrire ou à proposer au cours des consultations prénatales intermédiaires (accord professionnel).**

|                                                                                                                       | 3Cs       | 4 Cs      | 5 Cs      | 6 Cs      | 7 Cs      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mois de gestation                                                                                                     | 4<br>mois | 5<br>mois | 6<br>mois | 7<br>mois | 8<br>mois |
| <u>Examens à prescrire obligatoirement</u>                                                                            |           |           |           |           |           |
| <u>Glycosurie et protéinurie</u>                                                                                      | X         | X         | X         | X         | X         |
| 2e détermination (si non faite avant) du groupe sanguin                                                               | -         | -         | -         | -         | X         |
| <u>RAI : si Rhésus D négatif à toutes les femmes, et si Rhésus D positif, aux femmes avec un passé transfusionnel</u> | -         | -         | X         | -         | X         |
| <u>Sérologie de la toxoplasmose en cas de négativité du résultat précédent</u>                                        | X         | X         | X         | X         | X         |
| <u>Recherche de l'antigène HBs</u>                                                                                    | -         | -         | X         | -         | -         |
| <u>Hémogramme</u>                                                                                                     | -         | -         | X         | -         | -         |
| <u>Examens à proposer systématiquement</u>                                                                            |           |           |           |           |           |
| <u>2e échographie (entre 20 et 25 SA) (d)</u>                                                                         | -         | X         | -         | -         | -         |
| <u>3e échographie (entre 30 et 35 SA) (d)</u>                                                                         | -         | -         | -         | X         | -         |
| <u>Prélèvement vaginal avec recherche de streptocoque B (entre 35 et 38 SA)</u>                                       | -         | -         | -         | -         | X         |
| <u>Dépistage d'infections urinaires asymptomatiques à la bandelette urinaire</u>                                      | X         | X         | X         | X         | X         |
| <u>Examens à proposer éventuellement</u>                                                                              |           |           |           |           |           |
| <u>ECBU en cas d'antécédents d'infections urinaires, de diabète ou de bandelette urinaire positive</u>                | X         | X         | X         | X         | X         |

**3. Surveillance :**

- Albuminurie, glycosurie, BA, Protéinurie positive → Craindre la pré-éclampsie
- Sérologie toxoplasmose, rubéole. (< 18SA)
- Examens obligatoires : RAI (6,8 mois) - NFS (6 mois) - Hépatite B (6mois) → **Systématique +++**

**4. Examens recommandés : 6mois**

- Dépistage de la bactériurie asymptomatique : BU, ECBU
- Dépistage du diabète gestationnel : FDR, GAJ ? Hgpo 75g h0, h1, h2 : 24-28SA
- Dépistage hépatite C: (AC antiVHC) grossesse à risque
- Sérologie VIH : si sérologie négative TI chez Gr à risque
- PV (? Streptocoque B): 34-38SA
- Prescription systématique d'antiD (300 pg) 28SA

| Durant la grossesse (de la 2 <sup>e</sup> à la 7 <sup>e</sup> consultation - du 4 <sup>e</sup> au 8 <sup>e</sup> mois) |         |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| Situations à risque                                                                                                    | Suivi   | Structure                                                          |
| <b>FACTEURS DE RISQUE GÉNÉRAUX</b>                                                                                     |         |                                                                    |
| Traumatisme abdominal                                                                                                  | A2      | À adapter en fonction de la pathologie générée par le traumatisme  |
| Accouchement secret sous x                                                                                             | A1      | Unité d'obstétrique                                                |
| <b>TOXIQUES</b>                                                                                                        |         |                                                                    |
| Usage de drogues illicites (héroïne, méthadone, ecstasy et cocaïne )                                                   | A2      | À adapter                                                          |
| Cannabis                                                                                                               | A1      | À adapter                                                          |
| Alcool                                                                                                                 | A2      | À adapter selon degré d'alcoolémie                                 |
| Tabac                                                                                                                  | A1      | Unité d'obstétrique                                                |
| Consommation de médicaments potentiellement tératogènes ou toxiques (exposition avérée)                                | A2      | À adapter                                                          |
| Intoxication au plomb                                                                                                  | B       | Unité d'obstétrique                                                |
| Oxyde de carbone                                                                                                       | B       | À adapter                                                          |
| Irradiation                                                                                                            | A2      | Unité d'obstétrique si aucune répercussion                         |
| <b>FACTEURS DE RISQUE MEDICAUX</b>                                                                                     |         |                                                                    |
| Diabète gestationnel                                                                                                   | A2      | À adapter                                                          |
| HTA gravidique (selon les chiffres tensionnels)                                                                        | B       | À adapter                                                          |
| Néphropathie gravidique (protéinurie isolée)                                                                           | B       | À adapter                                                          |
| Thrombose veineuse profonde                                                                                            | B       | À adapter                                                          |
| Coagulopathies et thrombopénie maternelles                                                                             | B       | À adapter                                                          |
| Anémie gravidique                                                                                                      | A       | À adapter en fonction de la sévérité et de l'étiologie             |
| Récidive d'infection urinaire basse (plus de 2)                                                                        | A1      | Unité d'obstétrique                                                |
| Pyélonéphrite (cf. Infections urinaires)                                                                               | A2      | À adapter                                                          |
| Vomissements gravidiques sévères (perte de poids, troubles ioniques, hépatiques...)                                    | A2<br>B | Unité d'obstétrique<br>À adapter                                   |
| - au 1 <sup>er</sup> trimestre de grossesse<br>- au 2 <sup>e</sup> ou 3 <sup>e</sup> trimestre de grossesse            |         |                                                                    |
| Cholestases gravidiques                                                                                                | B       | À adapter                                                          |
| <b>MALADIES INFECTIEUSES APPARUES/CONSTATEES</b>                                                                       |         |                                                                    |
| Toxoplasmose                                                                                                           | B       | À adapter si pathologie fœtale                                     |
| Rubéole                                                                                                                | B       | À adapter si pathologie fœtale                                     |
| Infection à cytomégalovirus                                                                                            | B       | À adapter si pathologie fœtale                                     |
| Herpès génital primo-infection ou récurrence                                                                           | B       | À adapter si survenue durant 3 <sup>e</sup> trimestre de grossesse |

|                                                                                        |    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Infection à parvovirus B19                                                             | B  | À adapter si pathologie fœtale                                                      |
| Varicelle/ zona                                                                        | B  | À adapter si pathologie fœtale                                                      |
| Hépatite B aiguë                                                                       | B  | À adapter                                                                           |
| Hépatite virale A, C, D ou E                                                           | B  | À adapter                                                                           |
| Tuberculose                                                                            | B  | À adapter                                                                           |
| Infection VIH                                                                          | B  | À adapter                                                                           |
| Syphilis                                                                               | B  | À adapter                                                                           |
| Grippe                                                                                 | A1 | À adapter en fonction du terme et des répercussions materno-fœtales                 |
| Listériose                                                                             | B  | À adapter                                                                           |
| Paludisme                                                                              | B  | À adapter                                                                           |
| Chikungunya                                                                            | B  | À adapter                                                                           |
| Maladie périodontale                                                                   | A  | Unité d'obstétrique                                                                 |
| <b>FACTEURS DE RISQUE CHIRURGICAUX</b>                                                 |    |                                                                                     |
| Laparotomie en cours de grossesse                                                      | A2 | À adapter                                                                           |
| <b>FACTEURS DE RISQUE GYNECOLOGIQUES</b>                                               |    |                                                                                     |
| Cancer du col                                                                          | A2 | À adapter                                                                           |
| Fibrome(s) utérin(s) (prævia et/ou volumineux et/ou symptomatique et/ou endocavitaire) | A2 | À adapter                                                                           |
| Kyste ovarien                                                                          | A2 | Unité d'obstétrique                                                                 |
| Cancer du sein                                                                         | B  | À adapter                                                                           |
| Infections vaginales                                                                   | A1 | Unité d'obstétrique                                                                 |
| Vaginoses bactériennes                                                                 | A2 | À adapter                                                                           |
| <b>FACTEURS DE RISQUE OBSTETRICAUX</b>                                                 |    |                                                                                     |
| Traitement de l'infertilité (> 1 an)                                                   | A1 | Unité d'obstétrique                                                                 |
| Datation incertaine d'une grossesse de découverte tardive                              | A2 | Unité d'obstétrique                                                                 |
| Oligoamnios (< 37 SA)                                                                  | B  | À adapter                                                                           |
| Hydramnios                                                                             | B  | À adapter                                                                           |
| Pré-éclampsie, pré-éclampsie supposée, syndrome HELLP                                  | B  | À adapter                                                                           |
| Amniocentèse/ponction des villosités choriales                                         | A2 | À adapter en fonction de la pathologie concernée et du résultat du prélèvement      |
| Réduction embryonnaire                                                                 | B  | À adapter                                                                           |
| Pertes de sang persistantes                                                            |    |                                                                                     |
| - avant 16 SA                                                                          | A2 | Unité d'obstétrique                                                                 |
| - après 16 SA                                                                          | A2 | À adapter                                                                           |
| Hémorragies fœto-maternelles                                                           | B  | À adapter                                                                           |
| Hématome rétroplacentaire                                                              | B  | À adapter                                                                           |
| Béance cervicale                                                                       | B  | À adapter en fonction du terme atteint (cf. protocoles de réseaux entre 36 et 37SA) |

|                                                                                 |         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Menace d'accouchement prématuré                                                 | B       | À adapter en fonction du terme atteint (cf. protocoles de réseaux entre 36 et 37SA) |
| Grossesse gémellaire<br>- bichoriale<br>- monochoriale                          | A2<br>B | Unité d'obstétrique<br>À adapter                                                    |
| Grossesse triple                                                                | B       | À adapter                                                                           |
| Incompatibilité foeto-maternelle (érythrocytaire et plaquettaire)               | B       | À adapter                                                                           |
| Diagnostic prénatal/suspicion de malformation ou de pathologie congénitale      | A2      | À adapter en fonction de la pathologie et du résultat                               |
| Retard de croissance fœtale                                                     | B       | À adapter                                                                           |
| Mort fœtale <i>in utero</i>                                                     | B       | À adapter                                                                           |
| Anomalies de localisation du placenta                                           | B       | À adapter                                                                           |
| Placenta bas inséré avec métrorragies, placenta ou vaisseaux prævia après 32 SA | B       | À adapter en fonction du terme atteint                                              |
| Grande multipare (supérieur à 5)                                                | A1      | Unité d'obstétrique                                                                 |

## VI. Consultation du 9<sup>ème</sup> mois

- 37-39 SA
- But : **QEE +**
  - ✓ Pronostic de l'accouchement
  - ✓ Consultation anesthésique si pathologie (cardiopathie, pulmonaire), voie haute programmée
  - ✓ Contrôler les sérologies, RAI, infection urinaire, cervicovaginale (? strept B), bilan préopératoire

### Hauteur utérine

### Palpation

### Tractus génital et périnée: Anomalie anatomique

- ✓ Cloison cervicale .vaginale
- ✓ Diaphragme vaginal
- ✓ Vulve étroite périnée court → déchirures
- ✓ Périnée long → épisiotomie = Section du muscle élévateur de l'anus pour laisser passer le bébé lors de l'accouchement
- ✓ Qualité de la cicatrice d'épisiotomie
- Utérus : Malformé. Cicatriciel: compte rendu opératoire, suites post opératoires
- Obstacle : PP, fibrome

## VII. Conclusion

- Interrogatoire + examen clinique de qualité
- Examen complémentaires appropriés
- Détection des GAR, référence à temps
- Diminution de la morbidité et mortalité materno-fœtale

